

16 - 07- Les Psychothérapies - Pr. MANOUDI

(0:01 - 0:30)

Bonjour, on va voir maintenant les psychothérapies. Comme objectif, reconnaître les différents types de psychothérapies disponibles, citer leurs intérêts et leurs principales indications, mener une thérapie de soutien d'appoint auprès d'un patient qui en a besoin. Les psychothérapies, ce sont des méthodes de soins du psychisme qui provoquent la maturation de l'individu et la manœuvre de son adaptation sociale et ou la récupération de l'état d'équilibre bio-psycho-social antérieur à la maladie.

(0:30 - 0:55)

Elles ne font pas recours à l'administration des médicaments, bien sûr, et elles se basent essentiellement sur l'établissement d'une relation thérapeutique et privilègent la parole pour la prise en charge des patients. Elles se basent essentiellement sur l'alliance thérapeutique, la relation médecin-malade. Ce sont des traitements utilisant des moyens psychologiques.

(0:55 - 1:10)

Elles utilisent la relation verbale avec le patient, l'expression artistique, les relaxations et elles sont basées sur des méthodes codifiées. Elles reposent sur des références théoriques et précises. Elles répondent à des principes, à des théories.

(1:11 - 1:24)

Elles se fondent sur la relation, comme on a dit, médecin-malade. Elles utilisent des techniques soit individuelles, soit collectives. Il y a des techniques individuelles qu'on peut utiliser aussi en thérapie collective.

(1:25 - 2:04)

Dans les psychothérapies individuelles, on note surtout les psychothérapies analytiques, les psychanalyses, les psychothérapies de soutien, les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC, les psychothérapies à médiation corporelle et l'hypnothérapie. Dans les psychothérapies collectives, on a les psychothérapies de groupe, les psychothérapies familiales, les psychothérapies de couple, les psychothérapies institutionnelles et la sociothérapie. Les psychothérapies analytiques, les psychanalyses, elles visent à ramener à un niveau conscient le conflit intrapsychique refoulé, à l'affronter et ainsi à dépasser le stade de fixation initial.

(2:05 - 2:32)

On va voir comment ça se passe. Elles sont pratiquées par un psychanalyste. Dans la cure type, au début de l'instauration de ces psychothérapies, le patient est allongé sur un divan, le

thérapeute est placé derrière lui pour garder une neutralité bienveillante, pour que le patient ne voit pas l'expression de ce qu'il raconte sur le visage du thérapeute.

(2:33 - 2:56)

Il repose sur la libre association des idées. Le patient va être invité à raconter sa vie, à parler. Il peut commencer de là où il veut, soit de son enfance, soit de l'état présent, et il peut faire des va-et-vient entre le passé et le présent et raconter son histoire.

(2:56 - 3:16)

L'analyste est invité à ne rien omettre, donc laisser le patient parler. C'est à ce moment-là que le patient commence à parler, qu'il va faire ressortir tout ce qu'il a caché dans son inconscient. Il va le faire remonter vers son conscient, l'affronter et le dépasser.

(3:17 - 3:38)

Donc vous voyez que c'est le patient qui fait tout l'effort. L'interprétation par le thérapeute du matériel verbal et onérique peut aider le patient à faire face à ce qu'il a caché dans son inconscient et à l'affronter et à le dépasser. Il peut y avoir une création d'une relation de transfert.

(3:38 - 3:58)

Le patient peut faire un transfert vers son thérapeute. Les séances durent une demi-heure à trois quarts d'heure, avec des horaires fixes de deux à trois fois par semaine pendant quatre à six semaines. Les indications principales de ces psychanalyses sont les états d'angoisse, les états d'inhibition et les troubles sexuels.

(4:01 - 4:21)

Il y a un autre type de psychothérapie analytique, c'est la psychothérapie d'inspiration analytique, qui est inspirée de cette cure type, la première. Elle a des références théoriques qui sont identiques à la première, c'est-à-dire qu'elle passe par les associations libres. Le patient commence aussi à raconter sa vie.

(4:22 - 4:32)

Elle utilise également la relation transférentielle. Le patient peut faire un transfert envers son thérapeute. Le thérapeute est aussi un analyste.

(4:32 - 5:00)

Mais là, le thérapeute et le patient sont assis en face à face, avec dans ce cas une intervention plus fréquente du thérapeute et des séances moins fréquentes. Dans la cure type, on a vu que le thérapeute, en général, n'intervient pas beaucoup jusqu'à la fin. Mais là, dans la cure avec

inspiration analytique, le thérapeute peut intervenir plus fréquemment.

(5:00 - 5:31)

Il a des indications plus larges, notamment toutes les névroses, même si maintenant on ne parle pas de névroses, et les états limites, les troubles de personnalité. Il faut bien sûr éviter les psychanalyses chez les psychotiques, parce que ça peut entraîner des complications. Le thérapeute, si il veut voir un psychotique, il a bien sûr des indications précises et il a les méthodes très précises.

(5:31 - 5:53)

Donc ça, c'est entre parenthèses. Les psychothérapies de soutien sont des techniques les plus utilisées en pratique. Ce sont des techniques que vous utilisez vous-même dans votre vie de tous les jours pour soutenir les gens autour de vous qui ont besoin d'un soutien, qui vous demandent conseils, qui vous demandent avis, qui vous demandent de l'aide.

(5:54 - 6:19)

Il n'y a pas vraiment de référence théorique, ni des techniques spécifiques. C'est le savoir-être et le savoir-faire de chacun que vous avez appris lors de votre éducation et que vous allez apprendre lors de votre formation médicale. Il se base sur l'écoute et l'interprétation prudentes d'un matériel conscient, la suggestion, la réassurance, l'encouragement et les conseils.

(6:20 - 6:40)

Donc c'est ça les bases de cette technique. Le but, c'est l'amélioration symptomatique avec une meilleure adaptation du sujet. Là, vous allez le faire plus fréquemment, comme vous allez rencontrer par exemple des sujets qui n'acceptent pas leur maladie physique, qui n'arrivent pas à s'adapter à leur maladie physique.

(6:41 - 6:52)

Le thérapeute peut agir sur le milieu extérieur par le soutien. Vous pouvez agir sur l'entourage, sur les conditions professionnelles du patient. Et il a une indication très large.

(6:52 - 7:10)

Donc toutes les pathologies psychiatriques, ils ont besoin de soutien. Toutes les maladies somatiques, organiques, autres, à un moment de leur évolution, ils ont besoin de soutien. Les thérapies cognitives ou comportementales, il y a deux types de techniques.

(7:10 - 7:22)

Il y a les techniques comportementales et les techniques cognitives. Et des fois, on utilise les

deux chez le même patient. Donc ces thérapies, bien sûr, elles répondent à des principes et des théories.

(7:22 - 7:28)

Elles sont bien codifiées. Donc elles agissent sur le symptôme et non sur la personnalité. J'insiste.

(7:29 - 7:36)

Donc les thérapies comportementales, on agit sur le comportement. On agit sur le symptôme. On n'agit pas sur la personnalité du sujet.

(7:37 - 7:57)

Le but de ces thérapies, c'est un déconditionnement d'un sujet pour transformer un comportement pathologique qui est acquis en une conduite qui est adaptée. Il y a plusieurs techniques. Et ils sont beaucoup plus utilisés dans les troubles anxieux, dans les dépressions et même dans les addictions.

(7:58 - 8:13)

Parmi les techniques, il y a l'exposition aux situations anxiogènes. L'exposition de façon graduée, de façon progressive pour permettre au sujet une désensibilisation. Par exemple, en cas d'agoraphobie.

(8:14 - 8:27)

En cas d'agoraphobie, le sujet a des attaques de panique, dont par exemple l'ascenseur. Il a peur de prendre l'ascenseur par peur d'avoir des attaques de panique. Il va éviter de prendre l'ascenseur.

(8:28 - 8:39)

Donc le comportement qu'il adopte, c'est un comportement d'évitement. C'est un comportement qui est pathologique, qui est acquis. Quand il est devenu agoraphobe, il a acquis ce comportement-là.

(8:39 - 8:48)

Donc il faut traiter ce comportement. On le traite par des techniques comportementales et on peut faire l'exposition graduée. On va l'exposer à prendre l'ascenseur.

(8:49 - 9:10)

Il y a des patients qui ont une phobie d'ascenseur, une agoraphobie, qui n'osent même pas

passer devant un immeuble où il y a un ascenseur. Donc premièrement, on va leur demander, on peut les accompagner. On peut les faire accompagner par un membre de la famille au début et après, on va les laisser aller seuls.

(9:11 - 9:29)

D'abord, passer devant un immeuble régulièrement, fréquemment, jusqu'à ce que le niveau d'angoisse diminue et disparaît. Après, on va leur demander de rentrer dans l'immeuble, aussi progressivement, jusqu'à ce que le niveau d'angoisse diminue. Après, aller devant l'ascenseur.

(9:29 - 9:39)

Après, on va leur demander d'appeler l'ascenseur. On peut faire ça sur plusieurs séances. Après, rentrer dans l'ascenseur et sortir, sans monter.

(9:39 - 9:52)

Après, on va leur demander de rentrer, de faire le 1, par exemple, et sortir. Après, faire le 1, monter au premier étage et sortir. On peut faire ça accompagné, après non accompagné, après monter au deuxième étage.

(9:52 - 10:10)

Vous voyez, c'est une exposition à la situation anxiogène et phobogène de façon graduée. Un autre exemple, les sujets qui ont le toque de lavage, qui se lavent beaucoup les mains. L'idée derrière, c'est qu'ils sont contaminés par un microbe.

(10:11 - 10:21)

Donc, il y a des sujets qui vont se laver par du savon, par de l'eau de javel. Ils vont se laver une centaine de fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire chez ces sujets-là ? C'est de l'inhibition conditionnelle.

(10:21 - 10:34)

Donc, on va leur demander de se laver, pendant la première semaine, que 90 fois. La deuxième semaine, 80 fois. La troisième semaine, 50 fois et ainsi de suite, de façon graduée et progressive.

(10:35 - 10:54)

Et on peut ajouter d'autres techniques. Par exemple, leur demander de se laver que avec l'eau de javel, par exemple, deux à trois fois par semaine. Après, ne se laver que avec du savon, jusqu'à ce que le niveau d'angoisse diminue progressivement et jusqu'à ce que la fréquence du lavage diminue et devienne normale.

(10:55 - 11:16)

On peut utiliser aussi, avant l'exposition à ces situations anxiogènes, de la relaxation. Et on peut utiliser aussi des techniques d'affirmation de soi pour permettre aux patients de mieux affronter ces situations anxiogènes. Parmi les situations anxiogènes où on utilise beaucoup plus de l'affirmation de soi, il y a la phobie sociale.

(11:17 - 11:39)

Pour la phobie sociale, on utilise beaucoup plus les techniques cognitives qui sont axées sur la prise de conscience par le patient de la distorsion avec laquelle il appréhende les événements de son existence. Ce sont des thérapies à court terme, en général, les TCC. Pour l'exemple des techniques cognitives, je vous donne l'exemple de la phobie sociale.

(11:40 - 12:09)

Quelqu'un qui a la phobie sociale émet en général la barre plus haute et a peur des critiques des autres. Par exemple, je vous donne l'exemple d'un enseignant qui a peur du jugement et des critiques de ses élèves. En train de faire un cours, il commence à avoir des symptômes, il commence à rougir, à trembler, à avoir des sueurs parce que dans sa tête, les autres devant lui vont le critiquer ou bien ils vont avoir des pensées humiliantes par rapport à lui.

(12:10 - 12:44)

Par exemple, quand il est en train de donner une conférence, il voit deux étudiants ou bien deux personnes en train de rigoler. Qu'est-ce qu'il va penser la personne qui a une phobie sociale ? Il va se dire qu'ils rigolent sur moi ou bien ils ne s'intéressent pas à ce que je dis ou bien j'ai dit quelque chose qui ne doit pas se dire ou bien j'ai fait des fautes ou bien ils ont remarqué que je tremble, ils ont remarqué que je rougis, ils ont remarqué que j'ai des sueurs. Donc c'est toujours des pensées négatives, c'est une distorsion négative de la pensée.

(12:45 - 12:56)

Donc il faut corriger cette distorsion négative de la pensée par des techniques cognitives. Donc les pensées qu'il a pensées, lui, c'est des pensées automatiques. Ils sont venus de façon automatique parce qu'il a peur.

(12:57 - 13:16)

Il n'a pas réfléchi, il n'a pas pensé à autre alternative. Donc au cours de la thérapie cognitive, on va l'aider à penser aux autres alternatives et progressivement, c'est les autres alternatives qui vont venir au premier plan quand il va être en train de donner une conférence. Par exemple, les autres alternatives.

(13:16 - 13:35)

Quand deux personnes sont en train de rigoler, il peut se dire, ils ont pensé à quelque chose et ils ont commencé à rigoler. Ou bien quelqu'un a dit à l'autre une chose et il a commencé à rigoler. Donc trouver les autres alternatives, trouver les autres hypothèses au comportement de l'autre.

(13:37 - 13:52)

Alors les techniques comportementales et cognitives, ce sont des thérapies à court terme sur trois à quatre mois en général. On a une fréquence de 15 à 20 séances d'environ une heure à une heure moins quart. Ce sont des traitements directives.

(13:53 - 14:11)

J'insiste, le thérapeute est actif et met l'accent sur les problèmes concrets et actuels du patient. Donc il va donner des exercices au patient, il va donner des consignes au patient. Le patient aussi doit collaborer, il doit exécuter les exercices et les consignes et suivre la thérapie.

(14:11 - 14:39)

Donc à la différence de la thérapie psychanalytique, le patient fait le plus grand travail. Donc l'indication, on a dit, elle est large, c'est dans la dépression, les troubles anxieux caractérisés, tous les troubles anxieux, le trouble panique, le TAG, la phobie sociale, l'état de stress post-traumatique, les phobies spécifiques. On l'utilise aussi dans les troubles de personnalité, dans les troubles du conduit alimentaire et dans les addictions.

(14:39 - 14:54)

Et il y a aussi les thérapies à médiation corporelle. Donc c'est les relaxations. Les techniques de relaxation sont les plus pratiquées comme techniques de médiation corporelle.

(14:54 - 15:11)

Elles consistent en l'apprentissage de la détente neuromusculaire puis en son contrôle. La décontraction musculaire aboutit à un tonus de repos basé d'une détente physique et psychique. Elles sont utilisées dans les états anxieux, les affections psychosomatiques, les symptômes fonctionnels.

(15:12 - 15:34)

Elles sont contre-indiquées, bien sûr, dans les états de dépersonnalisation et de mercèlement schizophrénique. Le mercèlement, le patient, il peut sentir des modifications au cours de son corps ou bien que son corps est coupé en morceaux. Elle est aussi déconseillée dans les troubles moteurs organiques, donc ça va de soi, et les atteintes articulaires sévères.

(15:37 - 16:07)

Le principe vient du fait que la perception d'une menace entraîne une émotion, une peur, une anxiété qui va entraîner des réactions physiologiques d'alerte. Donc tout le corps va se manifester, le cœur, la respiration va se modifier, les muscles aussi, avec augmentation du tonus musculaire. Et bien sûr, ceci va s'aggraver par la fatigue, par les douleurs, par les troubles de mémoire, les troubles de concentration.

(16:08 - 16:41)

Une relaxation musculaire va entraîner une émotion calme et va entraîner un repos psychique. Donc le repos physique entraîne le repos psychique, d'où l'intérêt de cette technique de relaxation. Donc on a deux types de relaxation liés à la relaxation de Jacobson qui a créé une méthode dont le but est la réduction volontaire du tonus musculaire au repos et définit la relaxation comme l'absence de toute contraction musculaire.

(16:42 - 17:23)

Le but de la relaxation est d'obtenir un calme dans le domaine psychique, c'est-à-dire de mettre le cortex au repos en diminuant le fonctionnement cérébraux, neuraux, musculaires excessifs en relaxant directement la partie périphérique de ce circuit. Le patient s'entraîne à observer ces schémas de tension et à les relâcher, concentrant son attention sur des états de tension musculaire qu'il provoque. Le sujet apprend à repérer ces tensions, puis il cesse son effort et porte son attention sur les nouvelles sensations qui sont alors identifiées comme celles du relâchement.

(17:24 - 17:55)

De répétition en répétition, il essaie d'approfondir les états de détente musculaire, son état étant diminué et son idée et qu'en diminuant ces tensions dites résiduelles, on a tenu l'impact émotionnel. Vous allez voir, si vous allez chercher les techniques de relaxation de Jacobson, ça commence par des contractions musculaires et des relâchements. Le sujet va sentir qu'il est maître de la situation, il peut contracter.

(17:56 - 18:24)

Au cours de la contraction, il va sentir la tension musculaire et au cours de la relâchement, il va se rendre compte de la relaxation et de l'apaisement. L'hypnothérapie, c'est un sommeil incomplet provoqué artificiellement et pendant lequel divers phénomènes peuvent apparaître spontanément ou en réponse à un stimulus. Il facilite la suggestion et la libération émotionnelle.

(18:25 - 18:52)

Quand on fait endormir un sujet, comme si on le met dans un état de sommeil, on va lui suggérer

des choses et il va pouvoir libérer ses émotions de façon spontanée, sans angoisse. Il est indiqué dans les symptômes de conversion, les manifestations somatiques de l'anxiété et dans les troubles sexuels. Là, on a des techniques pour mettre le patient sous hypnose.

(18:52 - 19:21)

Là, je vais vous citer une technique. Le thérapeute commence à dire au patient et le patient peut tomber dans le sommeil. Vous êtes bien, tranquille, vous respirez profondément, tranquillement, tous vos muscles se détendent, vos paupières sont lourdes, vous les fermez, vous sentez une agréable sensation de lourdeur vous envahir, vous êtes merveilleusement bien, vous glissez lentement, irrésistiblement dans un sommeil réparateur.

(19:22 - 19:41)

Là, c'est la façon de le dire qui va pousser le patient à tomber dans le sommeil. Une autre technique, c'est la technique de confusion. On va demander à une personne de penser à son pied droit, puis très vite et rapidement à sa main gauche, très vite encore à la couleur des yeux de son père et ainsi de suite.

(19:42 - 20:18)

On va continuer, continuer, continuer jusqu'à ce qu'il tombe dans le sommeil. Son esprit cohérent se trouve alors rapidement surchargé et préfère se réfugier dans la détente que lui propose par ailleurs le sommeil. Les thérapies de groupe reposent sur le phénomène de dynamique de groupe, sous forme d'un groupe de discussion, d'un groupe d'affirmation de soi et autres sous forme d'un psychodrame, des jeux de rôle ou bien des séances de théâtre.

(20:19 - 20:40)

Les psychothérapies familiales, elles ont pour but d'améliorer la communication au sein de la famille, surtout en cas de problème chez l'adolescent. Elles reposent sur des entretiens et l'alliance thérapeutique dans ce cas joue un rôle très important. Le thérapeute sollicit les rôles de chaque membre dans l'équipe du système et sont indiqués dans la schizophrénie.

(20:40 - 21:27)

Ça aide les familles à prendre en charge leurs patients, dans l'anorexie mentale, surtout les adolescents. Dans les addictions, ça aide les familles à comprendre leurs patients et dans les maladies alcooliques en particulier. Les psychothérapies de couple, elles s'adressent aux difficultés conjugales, surtout quand il y a absence de communication.

Ensemble de pratiques psychothérapiques qui tentent à modifier les relations conjugales perturbées. Les thérapies institutionnelles, elles sont centrées sur l'établissement, son équipement, le personnel et les relations dynamiques entre soignants et soignés. Ceux forment

d'ergothérapie, de sortie, d'activités physiques, avec des réunions du personnel, des réunions avec les patients.

(21:28 - 22:01)

La sociothérapie, ce sont des mesures sociales prises pour permettre une resocialisation progressive, surtout des malades mentaux, bien des malades qui ont un handicap particulier. Exemple, par exemple, l'établissement spécialisé, des ateliers protégés, des centres d'aide pour le travail, spécifiques pour les patients. Les addictions et psychothérapie, on a déjà vu cette partie dans le cours des addictions, donc vous pouvez la revoir ici ou bien dans le cours des addictions.

Merci.